

GUÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA — Técnica Grounding 5-4-3-2-1

Anclaje sensorial al momento presente · Para uso del terapeuta en sesión

El grounding sensorial 5-4-3-2-1 ancla al paciente al momento presente redirigiendo la atención desde el mundo interno (pensamientos, recuerdos, sensaciones amenazantes) hacia el entorno externo seguro y concreto. Interrumpe estados de hiperactivación, disociación leve-moderada y desbordamiento emocional.

Indicaciones: Crisis de ansiedad · Flashbacks iniciales · Disociación leve · Pánico · Desbordamiento emocional agudo

GUIÓN BASE — PASO A PASO

5 VISTA Ve

«Mira a tu alrededor y nombra cinco cosas que puedas ver ahora mismo. No tiene que ser nada importante — una silla, una ventana, el color de la pared.»

4 TACTO Toca

«Cuatro cosas que puedas tocar. Nota la textura de tu ropa, el asiento, tus propias manos. Nota cómo se siente cada superficie.»

3 OÍDO Oye

«Tres sonidos que puedas escuchar ahora. Cercanos o lejanos — el aire, voces fuera, tu propia respiración.»

2 OLFATO Huele

«Dos cosas que puedas oler. Si no percibes nada claro, simplemente inhala y nota el aire tal como es.»

1 GUSTO Saborea

«Una cosa que puedas saborear ahora mismo — el sabor que tienes en la boca en este momento.»

Cierre: «¿Dónde estás? ¿Qué año es? ¿Estás a salvo en este momento?» — Esta verificación final consolida el retorno al presente.

P1 Se desconecta más — la técnica aumenta la disociación

Por qué ocurre: En trauma complejo o disociación estructural, focalizar la atención puede profundizar la desconexión si no hay suficiente base de seguridad.

Qué hacer:

- Añadir estímulo físico intenso previo: «Apoya los dos pies en el suelo, nota el peso, aprieta las manos 3 segundos y suelta.»
- Usar temperatura como ancla: sostener un vaso de agua fría o poner las manos bajo agua fría.
- Añadir movimiento orientativo: girar la cabeza lentamente mirando la sala como si fuera la primera vez.
- Reducir a dos o tres sentidos (empezando siempre por tacto y vista).

P2 La ansiedad aumenta al focalizar la atención

Por qué ocurre: En hipervigilancia o pánico, «prestar atención» se interpreta como señal de peligro, disparando más activación.

Qué hacer:

- Dirigir la atención exclusivamente hacia el exterior, evitando sensaciones internas: «Solo mira la sala conmigo. ¿Qué ves?»
- Usar un objeto concreto como ancla principal: describir color, forma, sombra, brillo.
- Introducir movimiento suave primero: caminar tres pasos, sentir el suelo y volver a sentarse.

P3 Se bloquea, no puede nombrar nada

Por qué ocurre: La activación muy alta estrecha el campo atencional; el paciente no puede generar respuestas verbales.

Qué hacer:

- El terapeuta lidera activamente: «Mira — esa lámpara. ¿La ves tú también? Bien. Ahora esa ventana.»
- Eliminar la necesidad de contar: «No hace falta llegar a cinco. Dime solo una cosa que veas.»
- Usar contacto físico si hay permiso explícito previo: «¿Puedo ponerte la mano en el hombro? Nota ese peso.»

P4 Lo hace mecánicamente, sin efecto real

Por qué ocurre: El paciente ejecuta la técnica de forma automática sin anclar realmente la atención; se convierte en un ritual vacío.

Qué hacer:

- Añadir curiosidad genuina: «No me digas el nombre. Descríbemelo como si yo no pudiera verlo.»
- Pedir detalle sensorial real en lugar de etiquetas: color exacto, temperatura al tacto, dureza.
- Introducir novedad: «Busca algo en esta sala que nunca hayas mirado de verdad antes.»
- Alterar el orden de los sentidos para romper la automatización.

P5 Le parece artificial o infantil, no se engancha

Por qué ocurre: Alta capacidad intelectual, desconfianza hacia técnicas psicológicas o adolescentes: la brecha con el autoconcepto genera resistencia.

Qué hacer:

- Reformular en lenguaje neurocientífico: la técnica activa el córtex prefrontal e inhibe la amígdala, recuperando capacidad de pensar.
- Ofrecer como experimento sin expectativas: «Solo pruébalo una vez y cuéntame qué notaste.»
- Adaptar el lenguaje: «Vamos a hacer un escaneo sensorial del entorno.»

P6 Funciona en sesión pero no en casa o en crisis real

Por qué ocurre: La activación en contexto real supera a la de sesión; la técnica no está automatizada para competir con la respuesta de estrés agudo.

Qué hacer:

- Practicar en sesión con activación progresiva real, no solo en calma.
- Crear tarjeta física plastificada (5 pasos) que el paciente lleve siempre encima.
- Establecer un disparador corporal personalizado: la primera señal de activación = sacar la tarjeta.
- Versión de emergencia (30 seg): mira 3 cosas · toca 2 · respira 1.

RESUMEN RÁPIDO DE ADAPTACIONES

Dificultad	Adaptación clave
Mayor disociación	Estímulo físico intenso previo + reducir sentidos
Ansiedad aumenta	Solo exterior + objeto concreto + movimiento suave
Bloqueo sin respuesta	Terapeuta lidera + reducir demanda a 1 elemento

Ejecución mecánica	Detalle sensorial + novedad + variar orden
Resistencia / no se cree	Marco neurocientífico + enfoque experimental
No funciona en casa	Tarjeta física + disparador corporal + versión 30 seg